

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ (DGS)

Cellule Nationale de Veille et d'Anticipation Sanitaire

RAPPORT ÉPIDÉMIOLOGIQUE D'URGENCE – SOUCHE HANTAVIRUS-26

Sujet : Évaluation virologique, tension hospitalière et préconisations de santé publique.

Date d'édition : 16 Mai 2026

Classification : Public / Diffusable

I. ÉTAT DE LA PRESSION HOSPITALIÈRE ET DYNAMIQUE VIRALE

Depuis l'identification du patient zéro, les données consolidées par l'Institut Pasteur et le réseau des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) démontrent une accélération exponentielle des admissions.

La souche pathogène, identifiée sous la nomenclature *Hantavirus-26*, présente une virulence respiratoire inédite. Dans 12,5% des cas symptomatiques, elle entraîne un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) nécessitant une intubation.

- **Taux de reproduction de base (R0) :** Évalué à 3,8 (une personne infectée en contamine près de quatre autres).
- **Tension hospitalière :** Au niveau national, le taux d'occupation des lits en service de réanimation a atteint 94% ce matin à 08h00.
- **Conclusion médicale :** La saturation totale du système de santé interviendra sous 72 heures en l'absence de mesures de rupture des chaînes de transmission.

II. ORIGINE DU VIRUS ET ANALYSE VECTORIELLE

Les enquêtes épidémiologiques de terrain ont permis de retracer l'origine du cluster principal dans le "Secteur d'Aménagement Nord". Le vecteur de transmission primaire à l'humain a été identifié comme étant le rongeur sylvestre (*Apodemus sylvaticus*).

Afin d'écarter toute piste d'une anomalie environnementale due aux activités humaines, les autorités sanitaires se sont appuyées sur les relevés écologiques de printemps fournis par les services de l'urbanisme et de l'environnement. Ces audits, menés en

mars 2026 sur les chantiers du Secteur Nord, n'ont révélé aucune anomalie : l'indice de densité de population du vecteur était de **0,4%**, soit un niveau endémique parfaitement conforme aux normes (seuil d'alerte fixé à 1%).

La mutation du virus et sa transmissibilité accrue à l'homme relèvent par conséquent d'un **phénomène purement virologique et spontané**, imprévisible par les autorités publiques.

III. PRÉCONISATIONS SANITAIRES IMPÉRATIVES AU GOUVERNEMENT

Face à la menace imminente d'un effondrement capacitaire de nos hôpitaux, le Comité scientifique recommande au Président de la République et au Gouvernement l'activation immédiate des mesures prophylactiques suivantes :

1. **Confinement national strict** avec interdiction de déplacement, sauf dérogation motivée et justifiée par attestation.
2. **Fermeture intégrale des établissements d'enseignement** (crèches, écoles, collèges, lycées et universités) pour limiter le brassage de la population jeune, vecteur asymptomatique majeur.
3. **Application du télétravail** pour 100% des postes compatibles.
4. **Port du masque filtrant obligatoire** sur l'ensemble de l'espace public.

Ces mesures doivent être mises en application par décret dans les plus brefs délais pour garantir la sécurité sanitaire de la Nation.

Fait à Paris, le 16 Mai 2026.

Dr. Edward Victor

Ministre de la Santé et de la Prévention

Validé par le Haut Conseil de la Santé Publique